

Fecha Última Actualización: 01-07-2022 16:20:56

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Joedal Antonio Zamorano Navarro
Edad : 51a 0m 25d
Dirección : Nonato Coe 696 Depto 24 2 Piso

Rut : 11.884.641-9
Fecha Nacto: 06/06/1971
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1625226
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 7450 6627

N° Epicrisis
313524

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Cirugía Sector B - Mediana Compleji

Fecha Ingreso : 26/06/2022 22:05

Días Estadía : 5

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 01/07/2022 16:07

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

TRASPLANTE HEPATICO

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EPICRISIS UCI
01/07/2022

JOEDAL ANTONIO ZAMORANO NAVARRO
51 años
RUT 11.884.641-0

Motivo de ingreso a UCI

·Postoperatorio inmediato de trasplante hepático de donante cadavérico

olsquemia fría 6:25 H

oSoporte transfusional

§Glóbulos rojos 2 U

§PFC 10 U

§Plaquetas 10 U

§Crioprecipitados 10 U

oRequerimientos

§Sangrado aproximado 1500 cc

§Cristaloides 3000 cc

§Coloides 150 cc

§Bicarbonato 100 cc

§Balance hídrico +2280

§Solumedrol 500 mg + 250 mg

Antecedentes

·Ex tabaquista

·Daño hepático crónico por OH; CHILD C MELD Na 32

oHepatocarcinoma (único)

·ITU por KPN BLEE (2020)

Fecha Epicrisis : 01/07/2022 16:20

Página 1 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:57

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

HISTORIA CLÍNICA

Paciente ingresó en postoperatorio inmediato de trasplante hepático de donante cadavérico a la unidad de cuidados intensivos el 27/06/2022; IOT/ARM BVM Sat O2 96%, hemodinámicamente estable sin vasopresores; se suspende sedación, evoluciona hipertenso secundario a cuadro algico (que mejora con analgesia), se realiza exámenes de control e inicia Weaning, es extubado 19:35hs con cambio de interface CNAF 50/35%, con buena tolerancia. Enzimas heáticas, INR dentro de lo esperado. El 28/06/2022 se realiza ecografía doppler hepática sin evidencia de complicación quirúrgica. Sin conflicto de intercambio gaseoso. Evoluciona con oliguria, requiere administración de cristaloides / coloides EV sin respuesta diurética esperada.

En horas de la tarde presentó episodio súbito de dificultad respiratoria, taquicardia y deterioro del estado de conciencia, requiere intubación orotraqueal, se realizó cirugía exploratoria de cavidad abdominal que no evidenció complicación quirúrgica, posteriormente angio TC de torax que informa negativo para TEP y dilatación de cavidades derechas.

El 29/06/2022 se realizó ecoscopia y luego ecocardiografía transesofágica que demuestra dilatación de ventrículo derecho y aurícula derecha, PSAP estimada alrededor de 55, se suspende sedación, paciente despierta, lúcido, colaborador, obedece órdenes simples, PaFi alrededor de 200, se mantiene en ventilación mecánica con PEEP 5 y en presión soporte, inicia milrinona y terapia depletiva.

El 30/06/2022 se coloca cateter en la arteria pulmonar, se evidencia hipertensión pulmonar importante, POAP 25, PSAP alrededor de 55 - 60, se mantiene milrinona, en seguimiento por equipo de hepatología y trasplante hepático, se considera hipertensión pulmonar en estudio sin causa clara. En horas de la noche se suspende furosemina en infusión, se considera suficiente el balance negativo obtenido hasta ese momento, el 01/07/2022 creatinina alrededor de 2.2 y natremia alrededor de 147, en la mañana paciente estable, sin noradrenalina, milrinona a 0.3 ug Kg min, lúcido, colaborador, entiende y obedece órdenes simples, aumento de enzimas hepáticas, se realiza ecodoppler hepática por parte de radiología, sin evidencia de complicación del injerto, se realizó ecocardiograma por cardiología que demuestra persistencia de dilatación de ventrículo derecho.

Presenta episodio súbito de disnea, suma taquicardia y paro cardiorespiratorio en actividad eléctrica sin pulso, inicia maniobras de reanimación avanzada según ACLS, por 45 minutos, sin éxito, fallece a las 11:05 H.

Se da aviso a la familia. La causa de muerte es insuficiencia o falla cardiaca aguda y disfunción ventricular derecha por hipertensión pulmonar, la etiología de éstas impresiona tromboembolismo pulmonar agudo, se propone a la familia realizar autopsia para corroborar este diagnóstico; rechazaN dicho procedimiento por que anatomía patológica podría realizarlo recién el 04/06/2022.

INFORME QUIRURGICO

HEPATECTOMIA: Laparotomía subcostal bilateral. Se aprecia hígado cirrótico, con lesión conocida no viable en LHD, sin ascitis. Extracción del hígado.

IMPLANTE: Anastomosis cavo-cava L-L. Anastomosis portal T-T. Reperusión retrógrada del injerto. Inicialmente se evalúa AHD para anastomosis arterial, pero finalmente se desestima por lumen pequeño y flujo subóptimo. Se prepara arteria hepática propia receptora, buen lumen, pared sana. Anastomosis arterial de hepática propia receptora a propia del donante.

Colecistectomía en directa. Anastomosis biliar ducto ducto T-T. Se instalan 2 drenajes JP en FD, lateral supra hepático y medial sub hepático. Laparorráfia.

Tiempo Isquemia Fría: 6 h 25 min / Solumedrol: 500 mg+ 250 mg (11:00)

Transfusión Masiva: Glóbulos rojos 2UI, PFC Plasma 10UI, Plaquetas 10 UI, Crioprecipitados 10UI

Hidratación: Cristaloides 3000ml / Albumina 150ml ¿ 3 fco/ HCO3 100ml ¿ 250mg

Balance total: ingreso 7080ml / egreso 4800 (diuresis 3300/Sangrado 1500) / Balance + 2280

EXAMEN FISICO

Paciente vigil, con restos de sedación, pupilas isocóricas normoreactivas, mucosas orales húmedas con TET, tórax simétrico con campos pulmonares ventilados, ruidos cardiacos rítmicos sincrónicos con el pulso, abdomen blando depresible, doloroso a la palpación con apósitos limpios y drenajes Jackson x2 (supra ¿ sub hepático), extremidades simétricas con movimientos activos coordinados.

Paciente presenta disnea súbita sin objetivarse obstrucción de vía aérea, suma taquicardia de hasta 140 latidos por minuto, evoluciona rápidamente a paro cardiorespiratorio en actividad eléctrica sin pulso, se inician maniobras de reanimación avanzada según ACLS, por 45 minutos, sin obtener retorno a circulación espontánea.

Paciente fallece a las 11:05 H
Se comunica a la familia

Diagnóstico de Egreso

Fecha Epicrisis : 01/07/2022 16:20

Página 2 de 3

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 01-07-2022 16:20:56

Página 3 de 3

Daño Hepático Crónico - TRASPLANTE HEPATICO
FALLA CARDIACA DERECHA

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

FALLECIDO

Plan Post Alta

SE REALIZO CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Guillermo Molina Mancero
Médico Tratante (Staff)